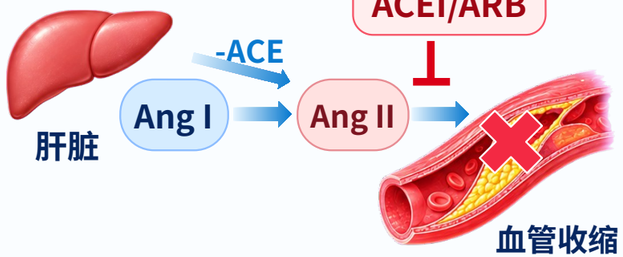
图 2 糖尿病肾病合并心血管疾病的药物协同治疗策略

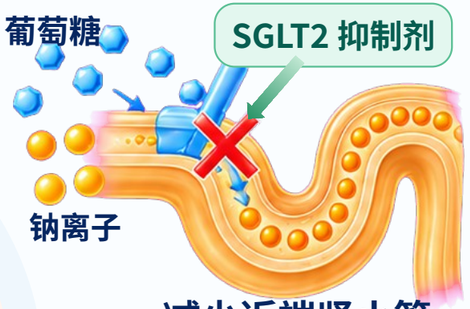
1 基础治疗： ACEI/ARB

肾素 - 血管紧张素系统阻断



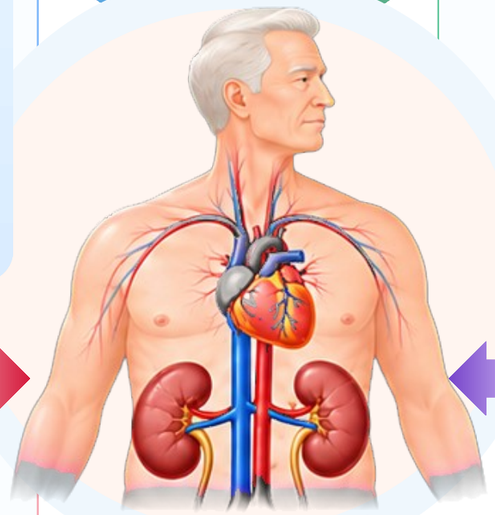
- 降压
- 降低肾小球内压
- 减少尿白蛋白
- 基础治疗

2 SGLT2 抑制剂



减少近端肾小管
葡萄糖和钠重吸收

- 减轻肾小管转运负荷
- 缓解肾小球高滤过
- 延缓 eGFR 下降
- 降低心衰住院风险



3 GLP-1 受体激动剂



- 改善血糖代谢
- 减重
- 降低动脉粥样硬化风险
- 改善肾脏结局

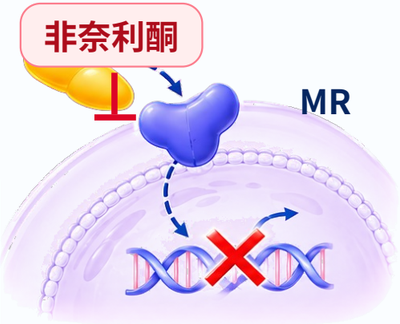
肾脏保护

- 延缓肾功能恶化
- 减少尿白蛋白

心血管保护

- 降低心衰风险
- 降低心血管事件

4 非甾体 MRA （非奈利酮）



阻断醛固酮 - 矿物皮质激素受体
抑制下游炎症与纤维化信号

- 降低尿白蛋白
- 减轻炎症
- 减轻纤维化
- 降低心血管风险

联合治疗需监测： 血钾、肾功能、血压、容量状态